

대변잠혈검사(FIT) 양성 안내

대변잠혈검사 (FIT/FOBT, Fecal Immunochemical Test) — 국가암검진에서 양성 판정을 받은 경우의 의미와 다음 단계 안내. **FIT 양성 = 대장암 확정이 아닙니다.** 대부분 용종·치질·염증이 원인이지만, 정확한 확인을 위해 대장내시경 (Colonoscopy)이 필요합니다.



분변잠혈 양성 = 놀라기보다 대장내시경 일정으로 연결하는 신호입니다.

FIT 양성, 무엇을 의미하나요?

대장암 양성예측도 (PPV)

5~10

% (90% 이상은 암 아님)

진행성 선종 발견율

~30

% (제거하면 암 예방)

FIT 대장암 민감도

~80

% (놓치는 경우도 있음)

권장 대장내시경 시점

≤6

개월 이내 (지연 금지)

왜 양성 나왔을까? · 다음 단계는?

흔한 양성 원인 · COMMON CAUSES

1. 대장 용종 (Polyp) — 가장 흔함, 제거하면 암 예방
2. 치질 · 항문열상 — 미량 출혈로 검출 가능
3. 염증성 장질환 — 궤양성 대장염·크론병
4. 게실 · 혈관이형성 — 노년층에서 흔한 출혈원
5. 대장암 (5~10%) — 조기 발견 시 5년 생존 90%↑
6. 위·소장 출혈 — 드물지만 가능 (위내시경 동반)

양성 판정 후 다음 단계 · NEXT STEPS

1. 담당 의사 상담 — 위험요인 평가 및 일정 조율
2. 대장내시경 예약 — 6개월 이내, 가급적 빠르게
3. 식이·약물 사전 안내 — 항혈전제 중단 여부 상담
4. 수면(진정) 내시경 시행 — 보호자 동반 필수
5. 용종 발견 시 즉시 제거 — 검사 중 절제·조직검사
6. 추적 일정 안내 — 조직 결과 따라 1~10년 주기

대장내시경 준비 체크리스트 · PREP

사전 확인: 아스피린·항응고제 중단/유지 여부를 처방의와 상담
2~3일 전: 씨 있는 과일·잡곡·해조류 등 섬유질 제한
전날 저녁: 장정결제 복용 (지시 시간 엄수)
당일 아침: 추가 장정결제 + 음식 금지
당일 내원: 수면 내시경 시 보호자 동반 필수

대장내시경을 미루지 마세요 · DO NOT DELAY

1년 이상 지연 시 진행성 선종·암 위험이 유의하게 증가
 국가암검진(National Cancer Screening Program) FIT 양성자는 **2차 검진 비용 지원 대상**일 수 있으나, 진정료·용종절제·조직검사 비용은 달라질 수 있음
 "증상 없으니 괜찮다" — 초기 대장암은 대부분 무증상
 FIT 음성으로 재검만 받는 것은 **권장되지 않음**

이런 증상이 있다면 즉시 연락 · DO NOT WAIT

다음 증상은 대장내시경 일정을 기다리지 말고 **즉시 외래로 연락**해 주세요. (☎ 031-893-4560) — **혈변 (Hematochezia, 선홍색·검붉은색)이 반복되거나** 변에 피가 묻어 나오는 경우 / **설명되지 않는 체중 감소** (3개월 내 5% 이상) · 지속적 복통 · 배변 습관 변화(설사·변비 교대) / **어지러움·피로감 지속** (철결핍성 빈혈 가능, Iron-deficiency Anemia) / 가족 중 50세 이전 대장암 진단력이 있는 경우.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국가암검진 권고안 (보건복지부·국립암센터) · 대한소화기내시경학회 대장내시경 가이드라인 · USPSTF Colorectal Cancer Screening 2021

본 자료는 일반적 권고이며, FIT 양성 판정 후 대장내시경(Colonoscopy)은 가능한 6개월 이내 시행을 권장합니다. 환자별 위험도와 동반질환에 따라 일정·준비법이 달라질 수 있으므로 담당 의사와 반드시 상담하시기 바랍니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/screening/fit-positive/